

ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΑΛΚΑΛΕΑ

Γενικά: Η κατάποση αλκαλικών καυστικών ουσιών είναι συχνότερη στις αναπτυγμένες δυτικές χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ακούσια (σπανιότερα εκούσια) κατάποση οικιακής Χλωρίνης (υποχλωριώδες νάτριο - NaClO) και διαλυμάτων αμμωνίας.

Οι βλάβες από αλκάλια προκαλούν νέκρωση των ιστών, με αποσύνθεση πρωτεϊνών και κολλαγόνου, σαπωνοποίηση των λιπών με ρευστοποίηση σε βάθος τυπικά στον οισοφάγο, με αποτέλεσμα θρόμβωση αγγείων, ιστική ισχαιμία, διάτρηση ή όψιμη στένωση.

Κλινική εικόνα: Η εσωτερική λήψη έχει ως αποτέλεσμα εγκαύματα στα χείλη, τη γλώσσα, τους βλεννογόνους του στόματος, του φάρυγγα και κυρίως στον οισοφάγο.

Μετά την κατάποση του αλκάλεως συνήθως εμφανίζεται αίσθημα καύσου και ισχυρός πόνος στο στόμα, στον φάρυγγα και στο επιγάστριο, έμετοι, διάρροιες και τελικά collapsus. Ο έμετος είναι βλεννοαιματηρός και μπορεί να περιέχει ακόμα και κομμάτια βλεννογόνων. Εφόσον το καταποθέν αλκάλι έχει προσβάλει το λάρυγγα εμφανίζεται οίδημα της γλωττίδας, βράγχος φωνής, συριγμός, σοβαρή δύσπνοια και μπορεί να επέλθει ασφυκτικός θάνατος.

Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να αναδείξει σημεία διάτρησης οισοφάγου (υποδόριο εμφύσημα, πνευμομεσοθωράκιο, πνευμοθώρακας) ή εισρόφηση (με πνευμονικά διηθήματα). Η απεικόνιση ελεύθερου αέρα κάτω από το διάφραγμα υποδηλώνει διάτρηση στομάχου.

Σε επαφή των καυστικών αλκάλεων με τους οφθαλμούς προκαλούνται σοβαρές βλάβες, όπως καταστροφή του κερατοειδούς με έντονο πόνο, δακρύρροια, διάτρηση και σχηματισμό ουλώδους ιστού, ειδικά αναλόγως του pH και της ποσότητας του διαλύματος (βλ. σελ. 210).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. **Απαγορεύεται η χορήγηση εμετικών (σιρόπι Ιπεκακουάνας) και η πρόκληση εμέτου.**
2. **Απαγορεύεται η έκπλυση στομάχου (είτε το θύμα είναι ληθαργικό, είτε σε εγρήγορση).**
3. **Απαγορεύεται – αυστηρώς – η χορήγηση όξινων διαλυμάτων ως αντιδότην (έντονα εξώθερμη αντίδραση),** παρά μόνον, ίσως, η χορήγηση μικρής ποσότητας οπού λεμονιού.
4. **Απαγορεύεται η χορήγηση ενεργού άνθρακα (Toxicarb),** διότι μπορεί να προκαλέσει έμετο, δημιουργώντας επιπλέον βλάβες από τη δεύτερη διάβαση της καυστικής ουσίας.
5. Για την άμεση αραίωση της συγκέντρωσης της καυστικής ουσίας χορηγούμε νερό ή γάλα, σε ποσότητες 50-150 ml για τα παιδιά και 60-300 ml για τους ενήλικες ασθενείς. Πολλοί αμφισβητούν τη χορήγηση γάλακτος, διότι δυσχεραίνει την άμεση ενδοσκόπηση, η οποία καλύτερα να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο 24ωρο νοσηλείας του ασθενούς.
6. Κύριο μέλημα αποτελεί η εξασφάλιση του αεραγωγού, καθώς και η διατήρηση επαρκούς οξυγόνωσης του ασθενούς. Χορηγούμε O₂ στα 8-12 lt/min, με στόχο SpO₂ > 90-92%.
7. Τοποθετούμε 3way (#18G) φλεβική γραμμή για στάγδην χορήγηση 1000 ml N/S ή R/L, και ελέγχουμε την ΑΠ, ενώ μεριμνούμε ώστε να διατηρείται η ΣΑΠ > 100 mmHg.
8. Επί πόνου, χορηγούμε Μορφίνη ή Πεθιδίνη ή Τραμαδόλη (1 amp. σε 500-1000 ml ορού).
9. Για τον έλεγχο της διέγερσης, χορηγούμε 1 amp. Stedon 10 mg, εντός 100 ml N/S (iv).
10. Η χορήγηση κορτικοστεροειδών είναι αμφιλεγόμενη. Μπορεί να ενδείκνυται εντός των πρώτων 4-6 ωρών από την κατάποση, ιδίως σε ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο για ανάπτυξη οισοφαγικών στενώσεων. Φαίνεται επίσης ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών βοηθά στην τέλεση της οισοφαγογαστροσκόπησης τις επόμενες ημέρες της νοσηλείας. Χορηγείται λοιπόν - για τους ανωτέρω λόγους - Δεξαμεθαζόνη (Dexaton) 1 amp. 8 mg (iv) ή Μεθυλπρεδνιζολόνη (Lyo-Drol) amp. 250 mg - 1 gr (iv), αμφοτέρω εφάπαξ.
11. Διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (HKT, BP, HR, RR και SpO₂). Η ενδοσκόπηση οισοφάγου, στομάχου και 12/λου θεωρείται βασική εξέταση και συνήθως συνιστάται τις πρώτες 12-48 ώρες μετά τη κατάποση της καυστικής ουσίας.